



CHIRURGIE PEDIATRIQUE

Sténose hypertrophique du pylore
Malformations congénitales duodénales
Malformations congénitales de l'intestin grêle
Malrotation intestinale
Mégacôlon congénital
Invagination intestinale



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

- **Historique:**

- - première décrite: **Beardsley** (1788);
- - description détaillée: **Hirschprung** (1887);
- - première opération sur la musculature pylorique: **Fredut** (1907);
- - opération améliorée ultérieurement : **Weber** (1908) et **Ramstedt** (1911).

- **Incidence:**

- - 1-3 cas pour 1.000 nouveau-nés;
- - plus rare chez la race afro-américaine et asiatique;
- - plus souvent en Europe du nord;
- - rapport garçon-fille = 4/1.



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Étiopathogénie:

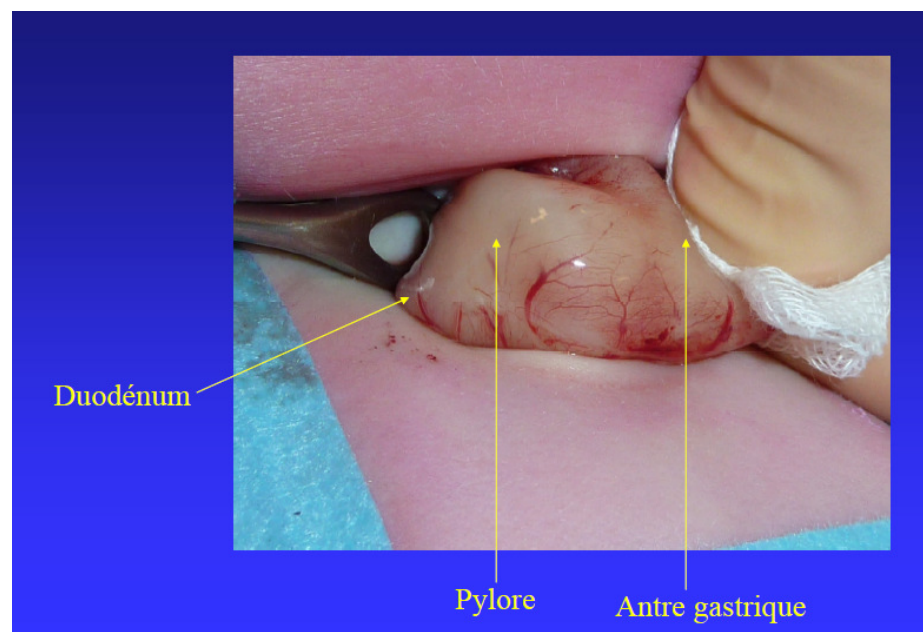
- **1) théorie malformative:**
 - - n.né avec une tumeur pylorique;
 - - existe un retard de maturation de plexus nerveux myentériques;
 - - des études récentes au ME ont infirmées partiellement cette théorie
- **2) théorie du spasme hypertrophié** - la musculature pylorique s'hypertrophie par hyperfonction sous l'action de l'**hypergastrine** qui existe chez ces enfants pendant la période néo-natale;
- **3) théorie endocrine:**
 - - dysfonction des glandes endocrines (Cervera);
 - - hypersécrétion d'adrénaline (Price);
- **4) facteur héréditaire** - dans approx. 10% des cas.



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

· Anatomie- pathologique

- **α Macroscopique:**
- - pylore de la taille d'une olive, couleur plus claire que celle de l'estomac et du duodénum;
- - présente à sa surface:
- - une vascularisation évidente de l'artère pylorique et des artères épiploïques;
- - sur la ligne médiane présente une zone "blanche", avasculaire.
- - la consistance du pylore est dure;

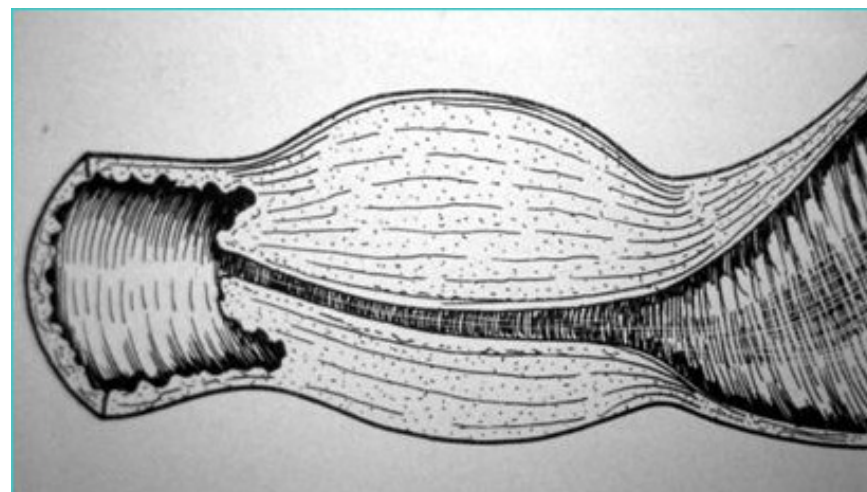




STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Anatomie pathologique:

- sur une section longitudinale: musculature pylorique grosse, atteignant quelques fois 1,5 cm (normal < 1 mm);
- dans le lumen pylorique la muqueuse est plicaturée, œdématisée
- **Malformations associées:**
 - méningocèle;
 - fissure labiale;
 - malformations ano-rectales;
 - pied tortu congénital





STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Symptomatologie:

- entre la naissance et le début de la maladie existe dans la plupart des cas un **intervalle libre de 14-21 jours** dans lequel l'enfant grandit et s'alimente normalement;
- 1) vomissements blancs** - symptôme dominant de la maladie:
 - le contenu gastrique expulsé est blanc, sans coloration bilieuse;
 - se produit immédiatement après le repas ou après 10-15 minutes, en même temps que l'onde de contraction gastrique;
 - au début l'enfant vomit une ou deux fois par jour;
 - avec le temps les vomissements deviennent plus fréquents, produisant un jet à distance;
 - le poids de l'enfant stagne, il se déshydrate, mais garde son appétit



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Symptomatologie:

- - avec le temps l'estomac se dilate, les vomissements deviennent rares mais abondants;
- - quelques fois les vomissements contiennent des stries de sang, provenant de l'effraction des capillaires de la muqueuse gastrique;
- - les selles sont rares (**constipation**),
- - **oligurie, alcalose hypochlorique,**
- - **hypopotassémie, hyponatrémie.**
- **2) péristaltisme gastrique** - ondes contractiles visibles dans l'épigastre;
- **3) palpation de l'olive pylorique** - dans l'hypochondre droit sous-hépatique pendant l'alimentation de l'enfant, ou en décubitus latéral gauche.



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Formes cliniques:

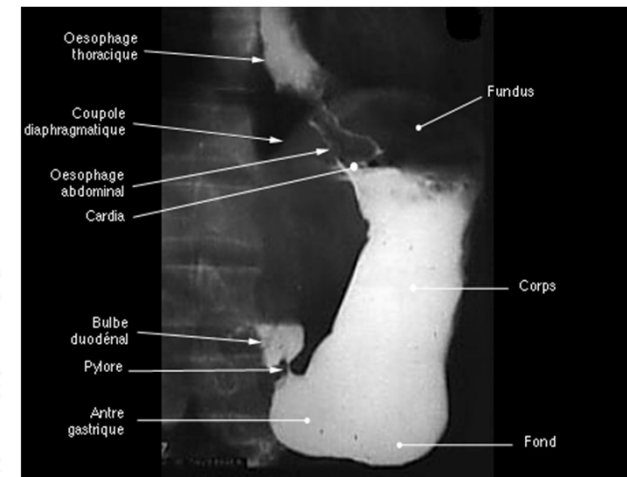
1. **formes précoces** - début dès la naissance par vomissements en jet, explosifs;
- olive pylorique petite mais très dure.
2. **formes communes** - avec début le 14-20ème jour;
3. **forme avec début tardif**: - à 2-3 mois, avec symptomatologie classique;
- danger accru de perforation de la muqueuse au niveau du cul de sac duodénal.
4. **forme ictérique** -SHP + ictère par bilirubine indirecte;
5. **forme hémorragique** - causée par des lésions de la muqueuse gastrique, résultat de la lutte pour vaincre l'obstacle pylorique + avitaminose K;
6. **syndrome phréno-pylorique Roviralta** = SHP + hernie hiatale



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Diagnostic positif:

- 1. signes cliniques;
- 2. examen radiologique:
 - a. signes de certitude:
canal pylorique filiforme,
allongé;

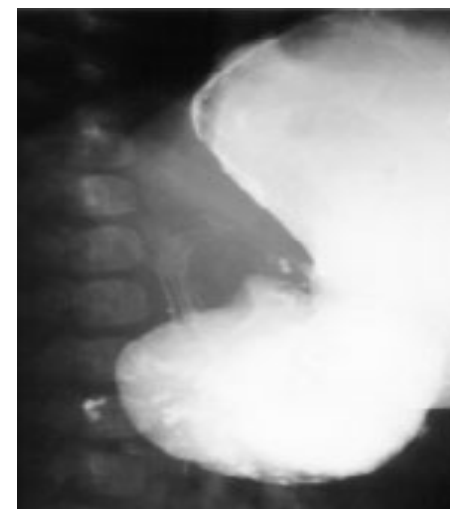
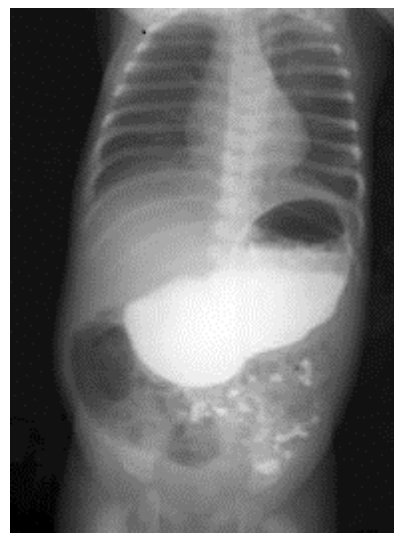




STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Diagnostic positif:

- **b. signes de probabilité:**
 - - stase gastrique,
 - -estomac dilaté,
 - -stagnation de la substance de contraste plus de 24 heures, même si le nourrisson a vomi;
 - - ondes péristaltiques gastriques puissantes dans la région antrale.



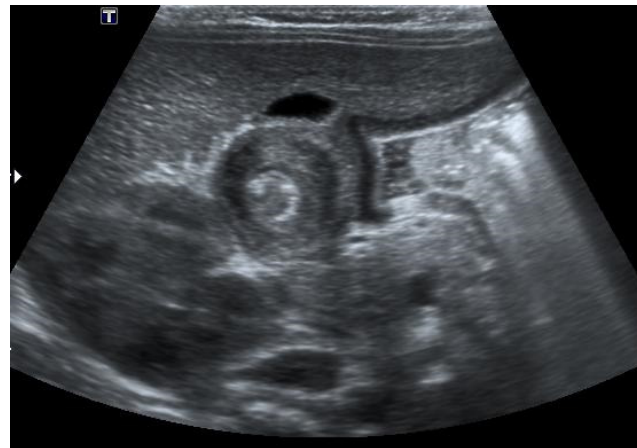
SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Diagnostic positif

- **3. ultrasonographie:** -
image de cocarde, centre hyper-échogène et couronne hypo-échogène, résultant de l'hypertrophie de la musculature pylorique.





STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

• Diagnostic différentiel:

- - régurgitations;
- - erreurs d'alimentation;
- - intolérance à certaines formes de lait;
- - spasmes pyloriques;
- - sténoses duodénales incomplètes;
- - malpositions cardio-tubérositaires;
- - hernie hiatale



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Traitement conservateur:

- - seulement dans la phase incipiente de la maladie;
- - administration d'anti spastiques: **atropine, belladone**;
- - lait en petites quantités mais alimentation fréquente;
- - après chaque vomissement : **lavage gastrique**;
- - administration de liquides par voie endoveineuse;
- - si après 1-2 semaine il n'y a pas de résultats, l'enfant va être opéré



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Traitement préopératoire:

- - **rééquilibrage hydro-électrolytique** conformément à l'ionogramme;
- - **glucose 10%** 75-100 ml/kgcorp/jour;
- - **NaCl, KCl, vitamine K.**
- - **antibiotiques** si bronchopneumonie d'aspiration;
- - **lavage gastrique** avec sérum physiologique.;
- - **sonde d'aspiration naso-gastrique**



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

· *Traitement chirurgical:*

- - anesthésie générale IOT;
- - incision longitudinale de 3-4 cm sur la ligne médiane dans l'épigastre ou transversale sous le rebord costal droit;
- - on pénètre dans la cavité péritonéale et on met en évidence l'olive pylorique;



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Traitement chirurgical:

- - **pylorectomie extra muqueuse Fredet** (incision de la séreuse et de la musculature pylorique dans la zone avasculaire);
- - possibles incidents intra-opératoires: perforation de la muqueuse pylorique vers le duodénum;
- - l'opération donne aussi de bons résultats par laparoscopie

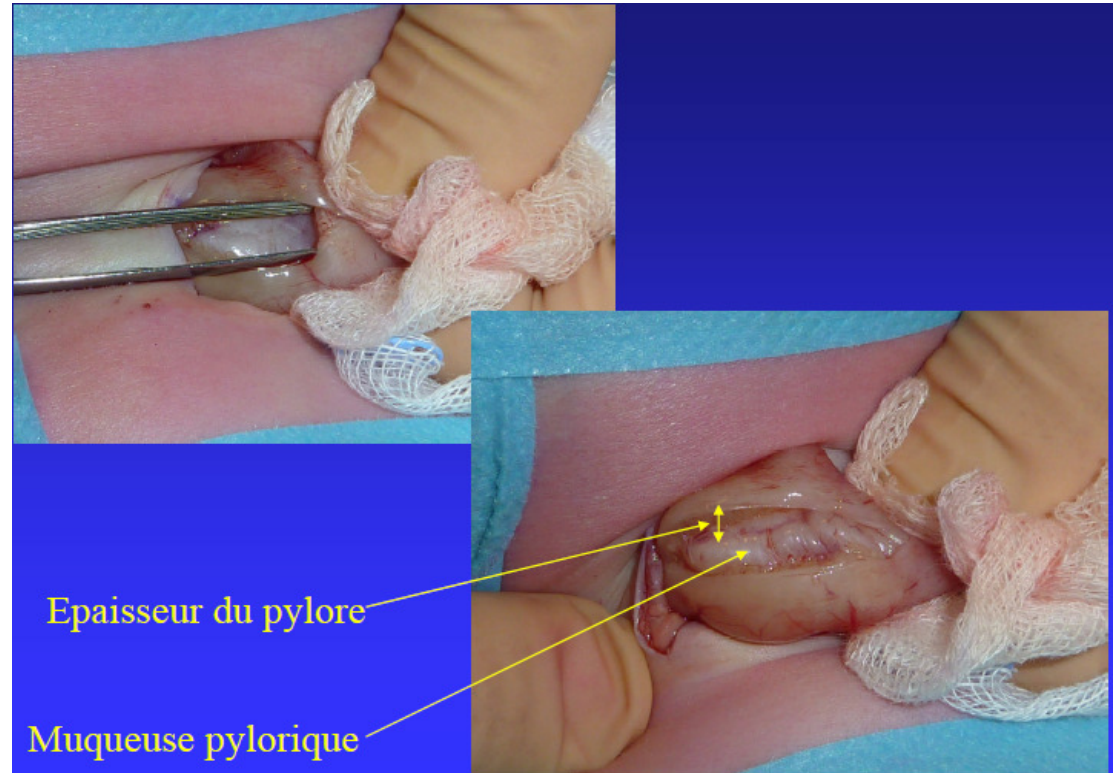


Pylorotomie extramuqueuse Fredet



STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Traitement chirurgical:





STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Évolution et pronostique:

- - **sans traitement:**
- - les vomissements fréquents déshydratent le nourrisson, donnant ainsi une perte de poids;
- - quand la perte de poids atteint 20-25% de la courbe pondérale, elle devient stationnaire;
- - visage: "masque de vieux", disparition de la bulle de Bichat;
- - exitus par troubles hydro-électrolytiques graves, tétanie, dénutrition, broncho-pneumonie d'aspiration.
- - **avec traitement médicamenteux** - très rare guérison des formes légères;
- - **avec traitement chirurgical** - évolution favorable pour la majorité des patients;
- - développement staturo-pondéral des nourrissons opérés ultérieur normal;
- - mortalité sous 0,5%.



Malformations congénitales duodénales

Les obstructions congénitales duodénales sont:

1. Obstructions duodénales intrinsèques:

1.1. Atrésie;

1.2. Sténose intrinsèque.

2. Obstructions duodénales extrinsèques:

2.1. Sténose extrinsèque.

3. Obstructions duodénales mixtes:

3.1. Pancréas annulaire



Malformations congénitales duodénales

ATRÉSIE DU DUODÉNUM

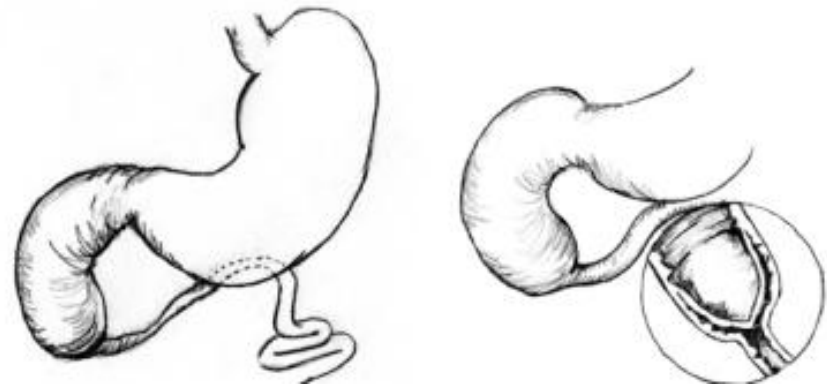
- l'incidence globale des malformations duodénales est de **1/10.000-20.000** naissances;
- le siège habituel des obstructions intrinsèques est le **segment II** duodénal sous l'ampoule de Vater;
- il existe **3 types d'atrésie** du duodénum:



Malformations congénitales duodénales

Atrésie de type I (membraneuse):

- la plus fréquente;
- segment proximal hypertrophié, le lumen devient brusquement étroit bloqué par un diaphragme muqueux.

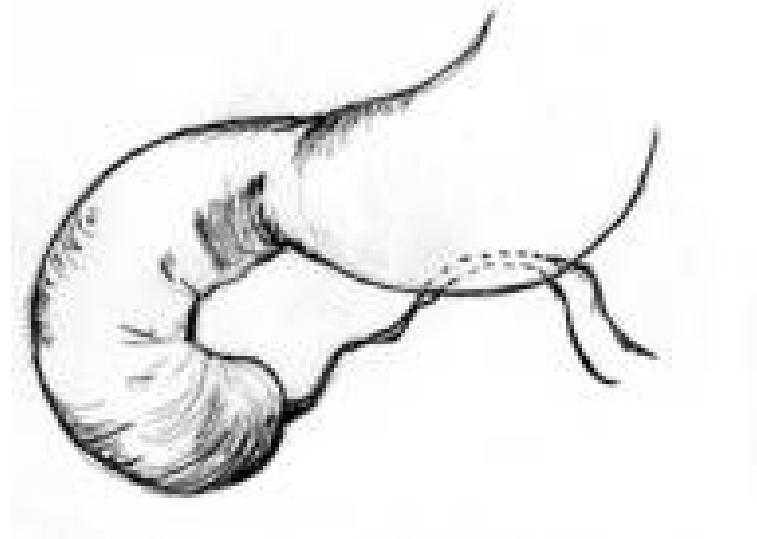




Malformations congénitales duodénales

Atrésie de type II (cordonale):

- segment proximal dilaté et hypertrophié, se continue par un cordon fibreux sans lumen avec le duodénum sub-atrésique aminci

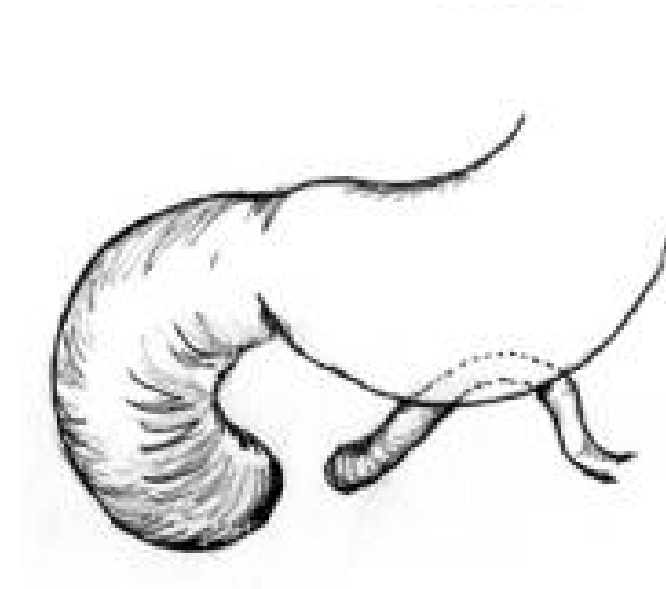




Malformations congénitales duodénales

Atrésie de type III (complète):

- segment proximal très dilaté et hypertrophié;
- sans aucune communication avec le segment distal

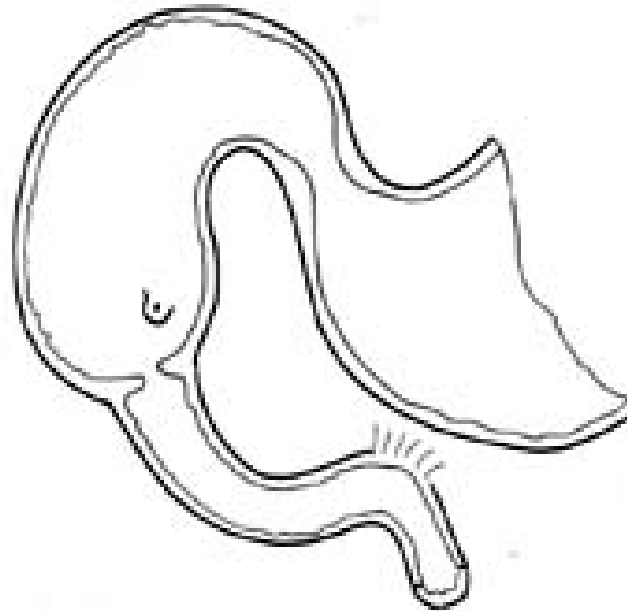




Malformations congénitales duodénales

STÉNOSE INTRINSÈQUE DU DUODÈNUM

- le diaphragme qui obstrue le lumen présente un orifice étroit qui ne permet pas le passage normal;
- dilatation et hypertrophie du segment proximal duodénal et de l'estomac.





Malformations congénitales duodénales

STÉNOSE ETRINSÈQUE DU DUODÈNUM

- par compression externe exécutée par le ligament **Ladd** - une bande du ligament pariétocolique droit dans le contexte d'un colon ascendant mobile, resté suspendu sur la ligne médiane à la place du colon transverse.



e



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Malformations congénitales duodénales

STÉNOSE ETRINSÈQUE DU DUODÈNUM

- une bande de tissus pancréatique qui entoure et entrecoupe la portion II du duodénum;
- est la conséquence d'un vice de développement du pancréas
- dans de rares cas, la veine porte située devant le duodénum, le comprime;



PANCRÉAS ANNULAIRE



Malformations congénitales duodénales

STÉNOSE ETRINSÈQUE DU DUODÈNUM

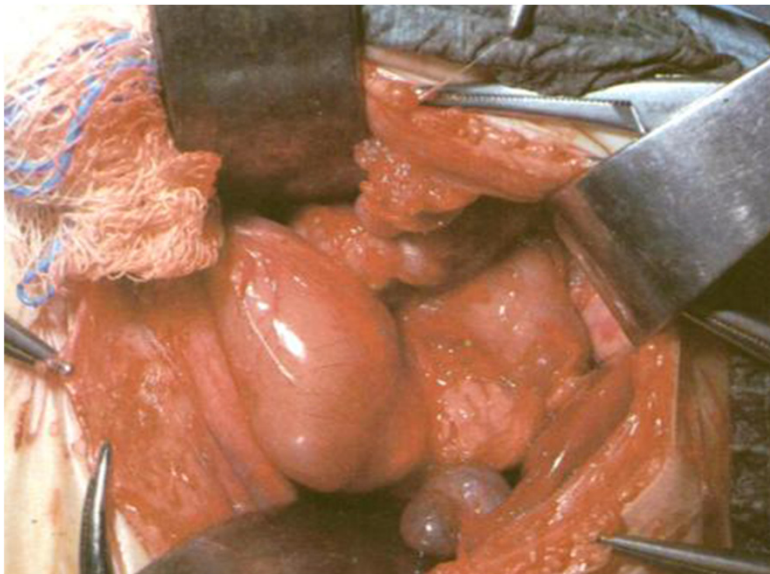
-Malformations associées :

- mongolisme dans 30% des cas;
- malformations cardiaques;
- autres malformations du tube digestif:
 - oesophage,
 - intestin grêle,
 - rectum;
- prématurité associée dans 50% des cas, étant un facteur de risque vital.

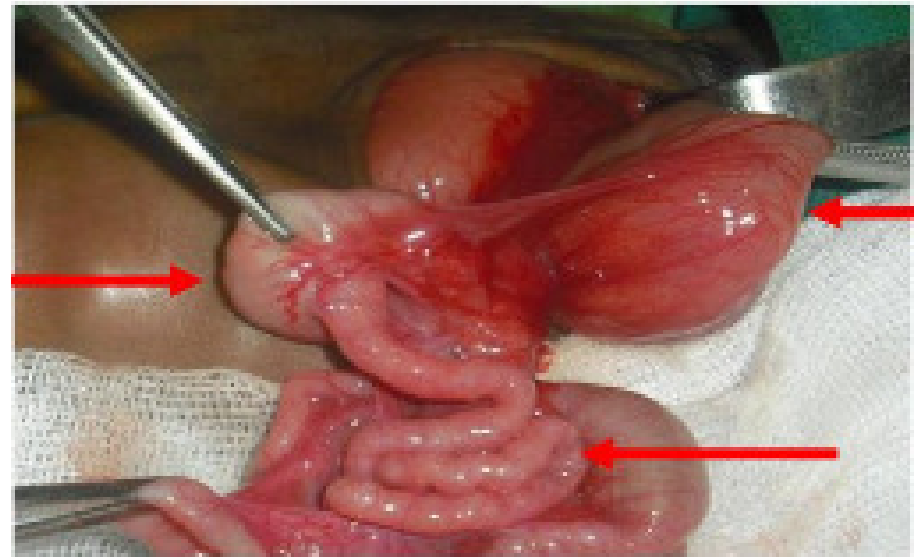


Malformations congénitales duodénales

Pancréas annulaire



Ligament Ladd.





Malformations congénitales duodénales

Tableau Clinique:

a. Atrésies duodénales:

- **vomissements bilieux** = symptôme dominant, apparaît dans 90% des cas dans les premières 24 heures;

"Tout nouveau né qui vomit de la bile, doit être suspecté d'obstruction mécanique intestinale jusqu'à preuve du contraire".

- autres causes de vomissements bilieux rares (hémorragie intracrânienne, gastrite néonatale);

- **absence de selle méconiale;**

- **contexte de grossesse qui a évolué en hydramnios**



Malformations congénitales duodénales

Tableau Clinique:

b. Sténoses duodénales: tableau varié en fonction de la sévérité de la sténose;

- dans les formes sévères se confond avec une atrésie;
- dans les formes avec orifice sténose plus large ;
 - les **vomissements** sont plus rares,
 - les **enfants sont constipés**,
 - dystrophiques** ,
 - développent difficilement**



Malformations congénitales duodénales

Diagnostic positif:

- sur les **signes cliniques**;
- sur l'**examen radiologique**:
- "**plaques de balance**" dans l'étage abdominal supérieur,
- l'**abdomen étant opaque**; dans l'étage abdominal inférieur



Rx aspect de plaque de balance

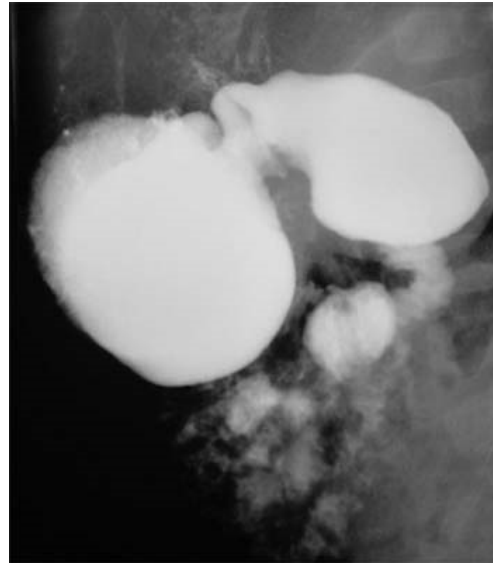


Malformations congénitales duodénales

Diagnostic positif: dans les sténoses

-l'examen radiologique:

-l'air pénètre par l'orifice sténotique et pneumatisé l'intestin déterminant l'utilisation de solution de contraste qui sera aspirée après l'examen;



Diaphragme incomplet



Malformations congénitales duodénales

Diagnostic différentiel:

- ***Atrésie jéjunale haute:***
- les vomissements ont les mêmes caractéristiques,
- distension abdominale est plus grande;
- radiologique - niveaux hydro-aériques.



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Malformations congénitales duodénales

Diagnostic différentiel:

- *Malformations cardio-tubérositaires (hernie hiatale):*
- **vomissements alimentaires** dès la naissance avec **stries sanguinolentes** qui s'arrêtent en position verticale.



Radiographie thoracique de face montrant une volumineuse hernie hiatale (niveau hydro-aérique en regard de l'aire cardiaque)



Malformations congénitales duodénales

Traitement

- **préopératoire**, suppose la correction des déséquilibres hydro-électrolytiques;
- **la technique opératoire** est en fonction du type d'obstruction:
Dans les atrésies de type I et les sténoses endoluminales:
 - **duodénotomie longitudinale,**
 - **excision de l'obstacle,**
 - **duodénoraphie transversale**

Dans les atrésies de type II et III:

- **anastomose termino-terminale.**

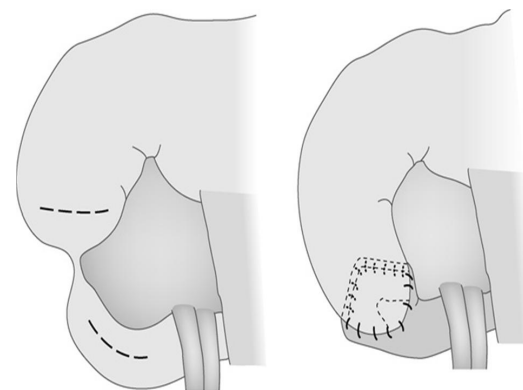


Malformations congénitales duodénales

Traitement

Dans les pancréas annulaires il existe trois possibilités:

- **duodéno-duodénostomie latérale;**
- **duodéno-jéjunostomie transmésocolique :**
désavantage: reprise tardive du transit;
- **gastro-jéjunostomie** avec risque d'ulcère peptique anastomotique (contre indiquée).



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA

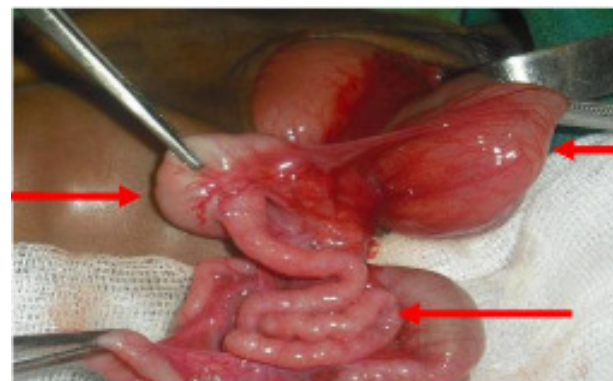


Malformations congénitales duodénales

Traitement

Sténose duodénale extrinsèque:

- **sectionnement de la bride Ladd.**



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Malformations congénitales de l'intestine grêle

-Incidence de 1/5.000-10.000 naissances.

-Théories étiopathogéniques:

- 1902 **Tandler** - théorie de l'occlusion embryonnaire du lumen intestinal;
- 1955 **Louw et Bernard** - théorie de l'accident vasculaire qui s'est produit dans la 10ème semaine après la réintégration de l'intestin dans la cavité coelomique, ou plus tard dans la vie intra-utérine par volvulus, invagination, strangulation



Malformations congénitales de l'intestine grêle

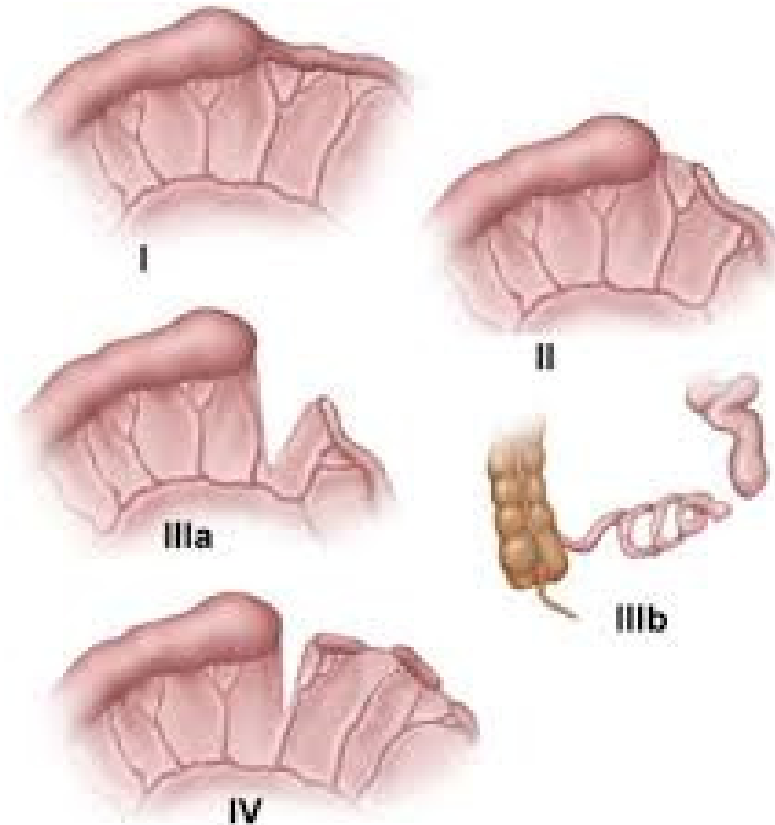
- **Anatomie pathologique:**

Type I:

- continuité de la paroi séro-musculaire avec lumen bloqué d'un septum de muqueuse complètement obstructif.

Type II:

- entre les segments fermés de l'intestin existe un cordon fibreux;
- le mésentère est intacte

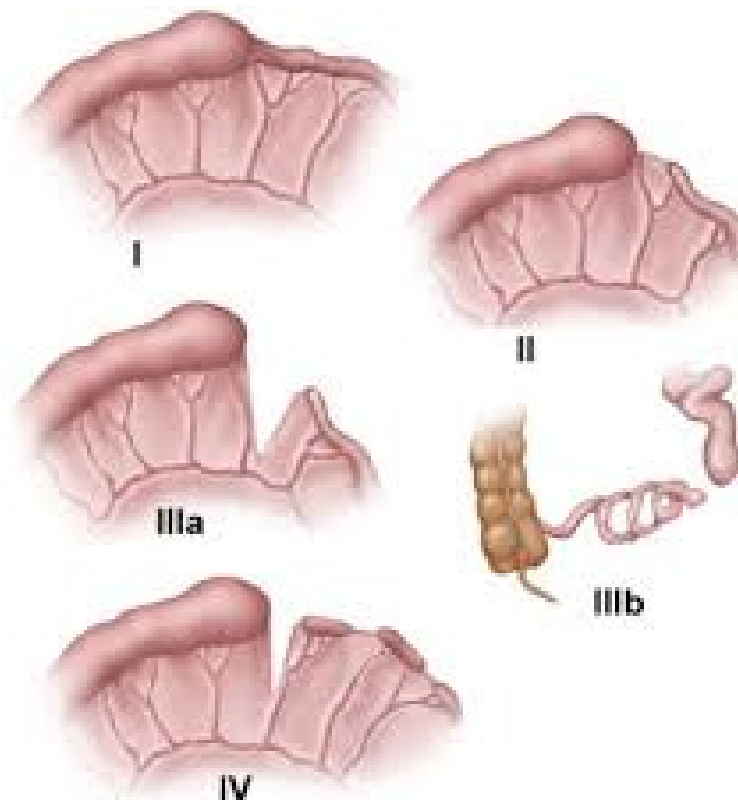




Malformations congénitales de l'intestine grêle

Anatomie pathologique:

- **Type III:**
 - les segments fermés sont complètement séparés;
 - défaut méésentérique en "V".
- **Type IV ("en pagode"):**
 - zones atrésiques multiples avec caractéristiques empruntées aux trois premiers types;





Malformations congénitales de l'intestine grêle

Anatomie pathologique:

- après la naissance, l'air pénètre dans le segment proximal qui se détend et souffre des troubles ischémiques avec nécrose et perforation en 2-3 jours





Malformations congénitales de l'intestine grêle

Signes Cliniques:

- Vomissements bilieux:

- le symptôme dominant dès le premier jour dans l'obstruction jéjunale;
- après 24 heures dans l'obstruction iléale ;
- dans les obstructions basses, à des
 - intervalles plus larges,
 - abondante,
 - initialement méconiale et ultérieurement fécaloïde;

“Le vomissement bilieux chez le nouveau-né est le symptôme capital de l'occlusion intestinale”



Malformations congénitales de l'intestine grêle

Signes Cliniques:

Distension abdominale:

- moins évidente dans les occlusions hautes (première moitié du jéjunum);
- la distension est d'autant plus marquée que l'obstacle est situé plus bas;
- **tégument détendu,**
- **dessin veineux évident;**
- **œdème supra-pubien et**
- **coloration verdâtre péri-ombilicale** : signes tardifs de péritonite;





Malformations congénitales de l'intestine grêle

Signes Cliniques:

- détermine des phénomènes **d'insuffisance respiratoire** par la limitation des mouvements du diaphragme;
- on peut observer les **ondes péristaltiques** de lutte

-Absence de transit méconial

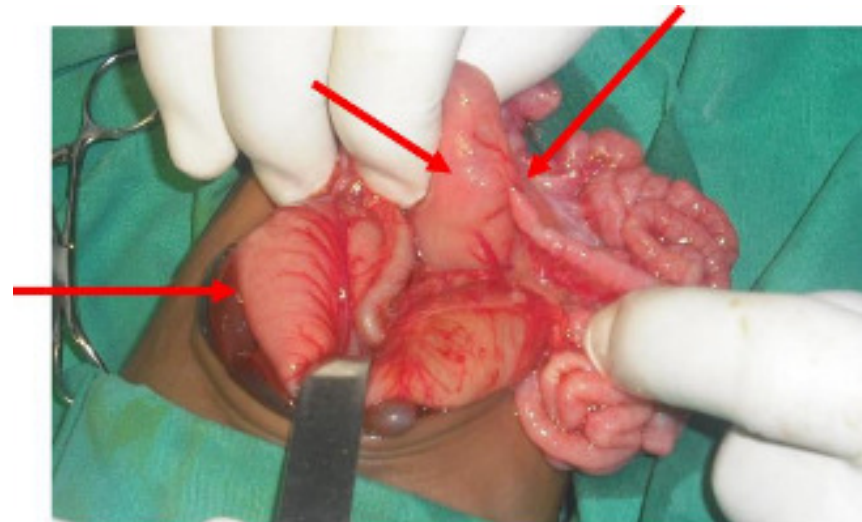
Touché rectal:

- élimination de mucosités et de quelques matières fécales de couleur grise



Malformations congénitales de l'intestine grêle

Atrésie d'intestin grêle – aspect intra-opératoire

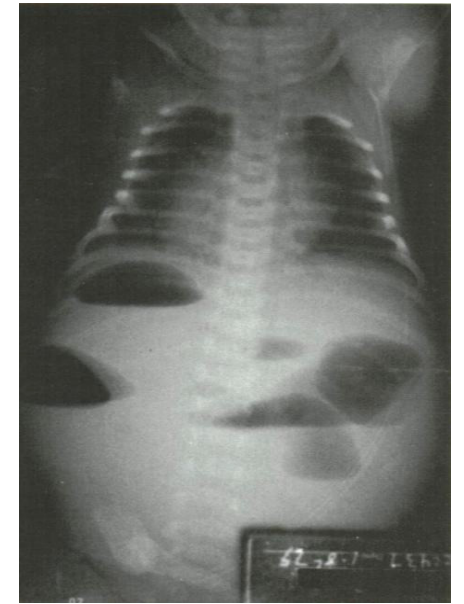




Malformations congénitales de l'intestine grêle

Examen radiologique:

- après la naissance, l'air pénètre dans le tube digestif, après 1 heure il atteint le jéjunum et après 3 heures la valvule iléo-caecale;
- radiographie simple, en position verticale : peut établir à peu près le siège des lésions en fonction du grade d'aération de l'intestin par mise en évidence des niveaux hydro-aériques;





Malformations congénitales de l'intestine grêle

Examen radiologique:

- atrésies avec siége dans l'iléon terminal et le colon, peuvent être confondues avec un mégacôlon congénital = demi-lune matte (non aérée) dans le pelvis



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Malformations congénitales de l'intestine grêle

Diagnostic positif

- Sur les signes cliniques;
 - vomissement bilieux,
 - distension abdominale,
 - transit intestinal absent;

- confirmé par radiographie simple.



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Malformations congénitales de l'intestine grêle

Diagnostic différentiel:

Mégacôlon congénital - vomissements bilieux,

-transit intestinal absent les premiers jours,

-aspect radiologique similaire,

-le touché rectal va évincier une ampoule rectale vide;

Iléus méconial - plus difficile à différencier,

fait pour lequel les vomissements bilieux et l'absence de selles méconiales sont des signes majeurs qui justifient une laparotomie d'urgence



Malformations congénitales de l'intestine grêle

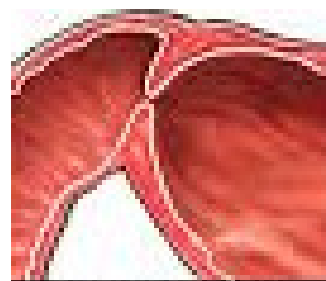
Traitement:

Préopératoire:

- sonde naso-gastrique pour prévenir la distension abdominale et les vomissements;
- perfusion endoveineuse avec rééquilibrage hydro-électrolytique.

Traitement chirurgical:

- laparotomie avec inventaire des lésions;
- procédé chirurgical - en fonction du type de lésions:
 - Dans l'atrésie membraneuse et les sténoses -**excision de l'obstacle muqueux et entéroplastie Heineke-Mikulicz;**





Malformations congénitales de l'intestine grêle

Traitement:

Dans le cas d'une dilatation marquée du segment proximal, on préfère la **résection de la portion dilatée, avec sectionnement oblique de l'intestin distal et section "cut back" sur le rebord anti-mésosténique.**

- la suture de l'intestin se fait en une couche totale ou extra-muqueuse, avec aiguille atraumatique





MALROTATION INTESTINALE

Définition:

- - se caractérise par la perturbation du processus physiologique de rotation et de fixation de l'intestin foetal;
- - la malformation peut rester asymptomatique toute la vie fait pour lequel l'incidence ne peut s'apprécier avec exactitude;
- - quelques fois est trouvée par hasard pendant d'autres interventions chirurgicales;
- - peuvent s'associer les inversions des autres organes parenchymateux résultant un "*situs inversus*";
- - peut avoir des conséquences graves de par les complications qu'elle génère, souvent mortelles ou invalidantes (par nécros et résection étendues);
- - les complications les plus fréquentes apparaissent dans les premières semaines de vie et chez les nourrissons plus grands (6-7 mois);
- - nécessitent un diagnostic rapide et un traitement efficace;
- - rapport garçon fille de 2/1;



MALROTATION INTESTINALE

Historique:

- - en 1898, **Mali** fait la première description du processus physiologique de rotation et de fixation intestinale;
- - en 1928, **Waugh** fait pour la première fois le rapport entre l'apparition du volvulus intestinal et le manque de rotation et de fixation intestinale;
- - **Ladd** a décrit pour la première fois le traitement des mal rotations;
- - **Lyndur** compare le processus de rotation intestinale avec le mouvement d'une corde autour d'un axe représenté par l'artère mésentérique supérieure.



MALROTATION INTESTINALE

Étiologie:

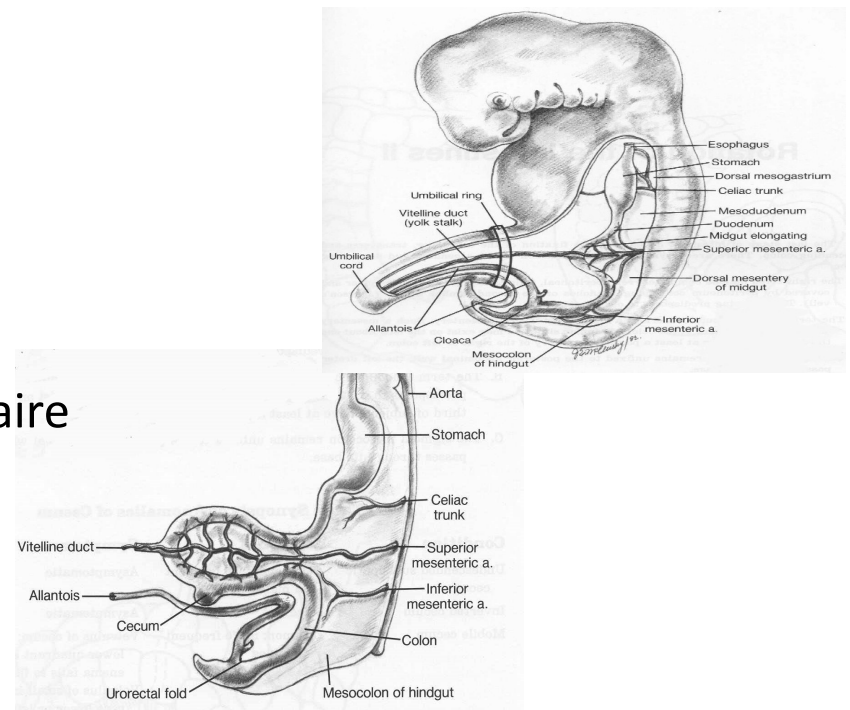
- - les causes de la maladie ne sont pas clairement établies;
- - le facteur déclencheur de la torsion intestinale autour de l'axe mésentérique non-fixé est un péristaltisme exagéré ou une distension brusque de l'intestin grêle;
- - diverses formes de mal rotation intestinale apparaissent par perturbation du processus physiologique de rotation et de fixation intestinale;
- - ce processus se déroule pendant les trois premiers mois de vie intra-utérine;
- - au début de la 3ème semaine, l'intestin primitif a 3 parties distinctes:



MALROTATION INTESTINALE

phase 1

- l'intestin primitif est une structure tubulaire uniforme, vascularisée de la partie postérieure des vaisseaux mésentériques supérieurs;
- il s'allonge au niveau de la portion intermédiaire selon un plan sagittal et sort de la cavité coelomique (vésicule ombilicale)





MALROTATION INTESTINALE

phase 2

- l'intestin primitif intermédiaire, extracoelomique, se tourne de 180° dans le sens antérieur autour de l'axe mésentérique;
- survient la réintégration intra abdominale de l'intestin
- la fin de la deuxième phase est marquée par la rotation du duodénum vers le bas et la gauche des vaisseaux mésentériques;



MALROTATION INTESTINALE

phase 3

- se termine avec une dernière rotation antérieure de 90° provoquant le passage du caecum et du colon droit au dessus de vaisseaux mésentériques supérieurs vers la fosse iliaque droite.
- après une rotation complète de 270° va survenir la fixation du mésentère et la formation des fascias de coalescence



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MALROTATION INTESTINALE

Forme anatomo-clinique:

- *α Absence totale de rotation:*
- *α Le mesenter commun* une rotation antérieure de maximum 90°;
- - l'intestin grêle se trouve sous l'hémi abdomen produit droit, et le colon sous l'hémi abdomen gauche;
- - le phénomène de coalescence ne s'est pas



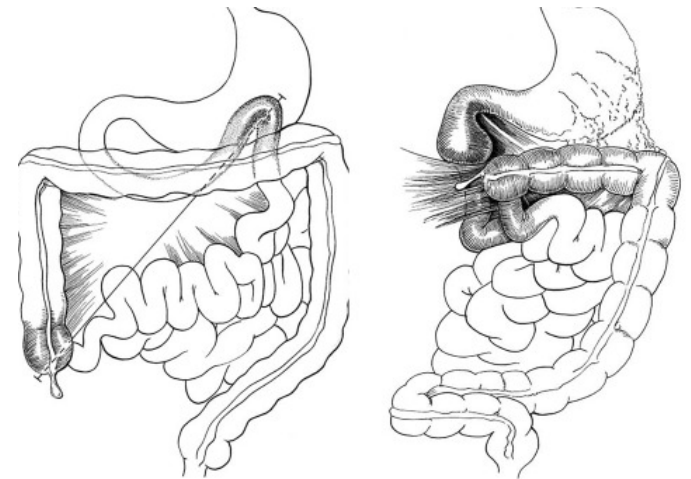
SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MALROTATION INTESTINALE

- **Forme anatomo-clinique:**

- ***α Rotation incomplète:***
 - - le processus de rotation intestinale s'arrête à 180°;
 - - le caecum se trouve sur la ligne médiane dans la région épigastrique
 - Le ligament pariéto-colique droite (Ladd) peut être une cause d'obstruction duodénale extrinsèque;
 - - peuvent exister une multitude d'aspects qui résultent de l'arrêt de la rotation intestinale dans différents stades intermédiaires;



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MALROTATION INTESTINALE

- **Forme anatomo-clinique:**
 - - des troubles de rotation intestinale apparaissent dans les hernies diaphragmatiques congénitales, omphalocèles, gastro-schizis, atrésies du duodénum ou de l'intestin grêle;
 - - peuvent s'associer avec un mégacôlon, diverticule Merckel et un syndrome Prune-Belly.



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MALROTATION INTESTINALE

Manifestation cliniques

- α **Présence du ligament Ladd**:- détermine l'obstruction duodénale.
- α **Volvulus intestinal**: - est déterminé par l'absence des structures fixes intestinales, la torsion intestinale se faisant en sens horaire;
 - - **le début brusque en plein état de santé avec pleurs, vomissements bilieux et distension abdominale épigastrique rapide progressive;**
 - - très vite la qualité des vomissements change et devient **fécaloïde** et ayant même un **contenu sanguin**;
 - - peut s'installer **un oedème de la paroi abdominale** et même une **contracture musculaire**;
 - - l'émission de selles manque, ou quelques fois il existe une émission de **selles méléniques**;
 - - **l'état général se détériore rapidement.**



MALROTATION INTESTINALE

Manifestation cliniques

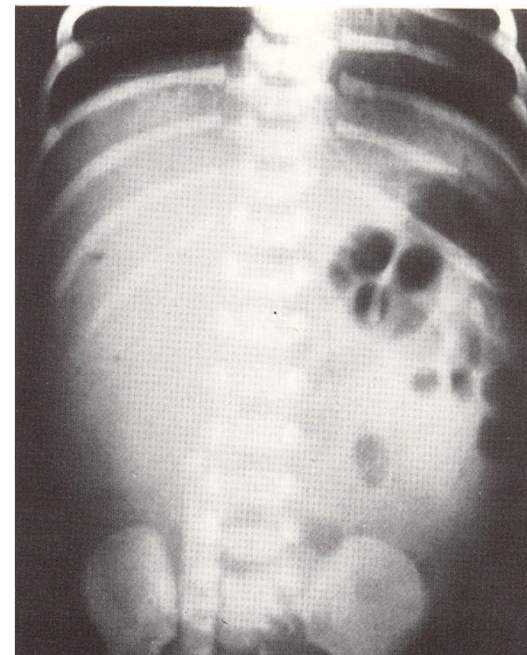
- **⌘ *Volvulus chronique***: - forme de volvulus partiel, bien tolérée, maladie de l'enfance et de l'adolescence;
- - se manifeste par des
- **douleurs abdominales colliquatives récurrentes,**
- **vomissements bilieux,**
- **malabsorptions de différents grades**
- **⌘ *Hernie interne***:
- - rare rencontrée, s'exprime cliniquement par un **tableau sous-occlusif** ou même **occlusif** en cas de strangulation;
- - dans la période néonatale nécessite un **diagnostic différentiel** avec les **sténoses duodénales extrinsèques**;



MALROTATION INTESTINALE

Diagnostic positif:

- sur la base du tableau clinique décrit;
- - l'exploration radiologique abdominale effectuée en orthostatisme met en évidence l'absence des images gazeuses coliques de l'hémi abdomen droit, ultérieurement de niveaux hydro-aériques;



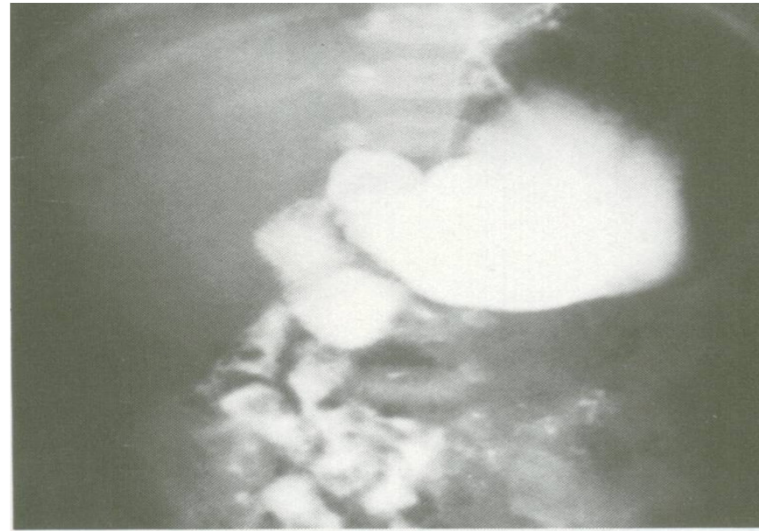
SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MALROTATION INTESTINALE

Diagnostic positif:

- - la radiographie avec solution de contraste indique la disposition de ceux ci en "tire-bouchon" - aspect caractéristique du volvulus;
- - le lavement barité met en évidence l'image classique de caecum pré-pylorique.





MALROTATION INTESTINALE

Traitement::

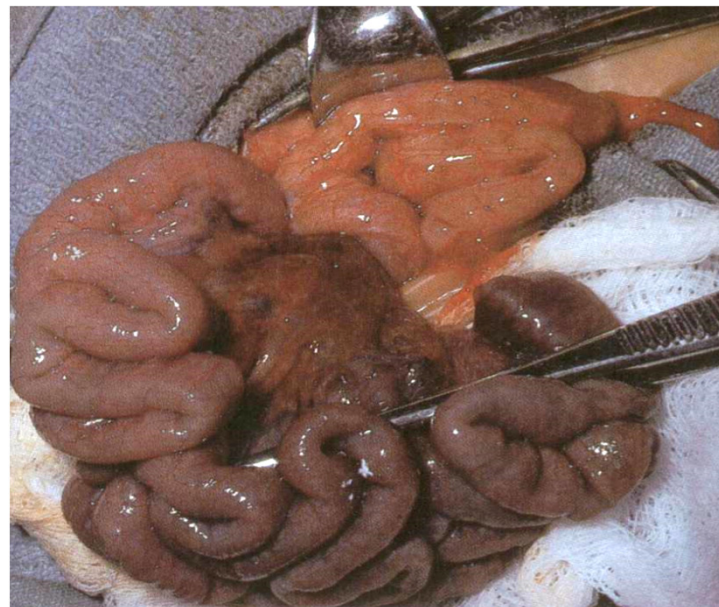
- est éminemment chirurgical et s'adresse qu'aux complications de la mal rotation (sténose du duodénum, volvulus, hernie interne);
- - le volvulus intestinal constitue **une urgence majeure**;
- - la préparation préopératoire va être réduite au maximum se limitant seulement à la thérapie antichoc et de réanimation;
- - la laparotomie médiane supra et sous-ombilicale offre une voie d'abord qui permet la résolution des lésions et des complications;
- - se mettent en évidence les anses intestinales détendues grises-violacées dans différents grades de stase, puis se fait le **détorsionnement** de l'intestin (d'habitude dans le sens horaire);



MALROTATION INTESTINALE

Traitement:

:





MALROTATION INTESTINALE

Traitement:

- - on vérifie ensuite le grade d'altération viscérale par appréciation de la réinstallation vasculaire et on évalue le besoin éventuel d'une **résection intestinale des zones compromises**;
- - quand les résections sont nécessaires sur une zone étendue ou si les segments intestinaux ne sont pas clairement viables **on ne fait pas de résection invalidante mais on revient après 24 heures (second look)**;





MALROTATION INTESTINALE

Traitement::

- - quand on met en évidence une anse volvulée avec perforation et extravasement du liquide intestinal intra péritonéal on réalise **la résection intestinale jusqu'au segment sain, la toilette et le drainage péritonéal**;
- - sont recommandées **les entérostomies dérivatives temporaires** à la place des **anastomoses termino-terminales**.





MALROTATION INTESTINALE

- **Complications post-opératoires:**
 - - occlusion intestinale par maladie adhérentielle;
 - - volvulus intestinal récidivant.
- **Pronostique:**
 - - dépend de la précocité du diagnostic, de la précision de l'intervention, de la longueur de la partie réséquée et du caractère de possible récurrence.